Клинические рекомендации

Саркоидоз

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**D86.0** — Саркоидоз легких **D86.1** — Саркоидоз лимфатических узлов **D86.2** — Саркоидоз легких с саркоидозом лимфатических узлов **D86.3** — Саркоидоз кожи **D86.8** — Саркоидоз других уточненных и комбинированных локализаций **D86.9** — Саркоидоз неуточненный
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 26.12.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Российское Общество Фтизиатров; Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов"; Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов" ; Российское респираторное общество; Общероссийская общественная организация Педиатрическое респираторное общество
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/736_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определения 3

2.2 Этиология и эпидемиология 3

2.3 Классификация 3

2.4 Клиническая картина 5

2.5 Саркоидоз ЛОР-органов и полости рта 5

2.6 Внелёгочные локализации 6

3. Диагностика 6

3.1 Критерии диагноза 6

3.2 Осмотр кожи, лимфоузлов и глаз 6

3.3 Анализы крови и мочи 6

3.4 Рентгенография и компьютерная томография органов грудной полости 7

3.5 Другие методы визуализации 7

3.6 Функция внешнего дыхания и ЭКГ 7

3.7 Биопсия 7

3.8 Дифференциальная диагностика 8

4. Лечение 8
4.1 Активное наблюдение 8
4.2 Системные глюкокортикоиды 8
4.3 Препараты второй и третьей линии 9
4.4 Другие методы лечения 9
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 9
5.1 Показания к госпитализации 9
5.2 Диспансерное наблюдение 10
6. Источник и актуальность 10
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 10

1. Основные положения

- Саркоидоз — системное воспалительное заболевание неизвестной этиологии с образованием неказеифицирующихся гранулём, мультисистемным поражением органов и активацией Т-клеток в очагах воспаления.
- Саркоидоз ЛОР-органов и полости рта составляет менее 1% случаев: синоназальная форма (заложенность носа, корки, носовые кровотечения, узелки на перегородке и верхней раковине), увеличение нёбных миндалин, поражение гортани с риском обструкции, сенсоневральная или кондуктивная тугоухость. Диагноз требует биопсии.
- Синдром Хеерфордта — Вальденстрёма: увеличение околоушных слюнных желёз, передний увеит, лихорадка, иногда паралич лицевого нерва.
- Диагноз верифицируется морфологически: гранулёмы без казеозного некроза хотя бы в одном органе при характерной клинико-рентгенологической картине; синдромы Лёфгрена, Хеерфордта, ознобленная волчанка позволяют поставить предположительный диагноз без биопсии.
- Бессимптомным пациентам без недостаточности органов показано активное наблюдение с оценкой **через 3 месяца**; системные глюкокортикоиды — при прогрессировании, угрозе функции органа или жизни.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Саркоидоз — системное воспалительное заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся образованием неказеифицирующихся гранулём, мультисистемным поражением различных органов и активацией Т-клеток в месте гранулёматозного воспаления с высвобождением различных хемокинов и цитокинов.

Синдром Лёфгрена — вариант острого течения саркоидоза, проявляющийся внутригрудной лимфаденопатией, узловатой эритемой, суставным синдромом и лихорадкой.

Синдром Хеерфордта — Вальденстрёма — вариант острого течения саркоидоза, проявляющийся увеитом, паротитом, лихорадкой и в ряде случаев сопровождающийся параличом лицевого нерва (паралич Белла).

Саркоидная реакция — образование локализованных групп эпителиоидно-клеточных неказеифицирующихся гранулём саркоидного типа в ответ на экзогенные факторы (импланты, татуировки, филлеры), при применении интерферонов, перифокально при злокачественных опухолях и паразитарных заболеваниях; в отличие от саркоидоза поражение только локальное.

2.2 Этиология и эпидемиология

Решающую роль играет воздействие окружающей среды на генетически предрасположенный организм. Вероятные триггеры — изменённые микобактерии, пропионовокислые бактерии, боррелии; саркоидная реакция возможна при применении интерферонов, индукторов интерфероногенеза и таргетной биологической терапии.

Саркоидоз встречается во всех возрастах и у обоих полов; в России преобладают женщины молодого и зрелого возраста. Синдром Лёфгрена наблюдается в 3,7–22% случаев, семейный саркоидоз — в среднем в 9,5%.

2.3 Классификация

Классификация внутригрудного саркоидоза по данным лучевого обследования

Стадия	Рентгенологическая картина	Частота
0	нет изменений на рентгенограмме органов грудной клетки	5%
I	увеличение внутригрудных лимфатических узлов, паренхима лёгких не изменена	45%
II	увеличение внутригрудных лимфатических узлов и изменения паренхимы лёгких	30%
III	изменения паренхимы без увеличения внутригрудных лимфатических узлов	15%
IV	выраженный фиброз лёгких как ведущий синдром	5%

Рентгенологическая стадия не отражает стадийность клинического течения; КТ точнее характеризует распространённость изменений. В диагнозе перечисляют все поражённые органы и системы.

1. **по локализации** — классический (внутригрудной), с преобладанием внелёгочных поражений, генерализованный
2. **по течению** — с острым началом (синдромы Лёфгрена, Хеерфордта — Вальденстрёма), изначально хронический, с фиброзированием, рецидив
3. **особые формы** — саркоидоз детей моложе 5 лет; саркоидоз, рефрактерный к системным глюкокортикоидам

Обострение — реактивация **в течение года** после окончания основного курса лечения; рецидив — возобновление проявлений **через 1 год и более** после лечения или спонтанной регрессии.

Признаки прогрессирования

1. ухудшение клиники, нарастание изменений в лёгких на КТ;
2. появление или усиление внелёгочных проявлений;
3. снижение ФЖЕЛ на **10% и более** или DLco на **15%** за 1 год;
4. формирование лёгочной гипертензии;
5. повышение АПФ, гиперкальциурия и (или) гиперкальциемия.

Построение диагноза

1. локализация (поражённые органы), при внутригрудном саркоидозе — рентгенологическая стадия 0–IV;
2. активность: 0 — неактивный, 1 — активный (или «синдром Лёфгрена», «синдром Хеерфордта — Вальденстрёма»);
3. течение: стабильное, прогрессирующее, регрессирующее, волнообразное, обострение, рецидив;
4. осложнения: недостаточность органа, стойкие структурные изменения;
5. подтверждение диагноза на клеточном или тканевом уровне.

2.4 Клиническая картина

Чаще течение малосимптомное, хроническое. Наиболее выражены жалобы при синдроме Лёфгрена и при «увеопаротидной лихорадке» — синдроме Хеерфордта — Вальденстрёма.

Синдром Лёфгрена (как правило, не дольше 2 месяцев)

1. лихорадка;
2. узловатая эритема;
3. двусторонний периартрит, преимущественно голеностопных суставов;
4. двусторонняя лимфаденопатия корней лёгких.

Общие симптомы

1. слабость и утомляемость (30–80%), оцениваются по шкале FAS;
2. лихорадка (20–60%) или длительный субфебрилитет;
3. боль, тревога, депрессия, когнитивная дисфункция, нейропатия мелких волокон.

При поражении лёгких и внутригрудных лимфоузлов — боль и дискомфорт в грудной клетке, одышка (оценивается по шкале mMRC), сухой кашель из-за давления увеличенных лимфоузлов на бронхи или раздражения гранулёмами нервных окончаний.

2.5 Саркоидоз ЛОР-органов и полости рта

Саркоидоз ЛОР-органов и полости рта составляет менее 1% случаев саркоидоза; чаще это случайные находки.

1. **синоназальный** — заложенность носа, ринорея, корки, носовые кровотечения, боль в носу, нарушения обоняния; эндоскопически — хронический риносинусит с узлами и мелкими узелками на перегородке и верхней раковине; необходима гистологическая верификация
2. **нёбные миндалины** — бессимптомное одно- или двустороннее увеличение, неказеифицирующиеся гранулёмы выявляются после тонзиллэктомии
3. **гортань** — дисфония, дисфагия, кашель; отёк и эритема слизистой оболочки, узелки и узлы; возможна угрожающая жизни обструкция; диагноз — по биопсии
4. **ухо** — снижение слуха, шум в ушах, глухота, вестибулярные расстройства; сенсоневральная тугоухость разной степени, реже поражение среднего уха с кондуктивной тугоухостью
5. **полость рта и ротоглотка** — опухание и изъязвление слизистой оболочки, языка, губ, дёсен; орофарингеальный саркоидоз может быть причиной обструктивного апноэ сна

Саркоидоз слюнных желёз (6%) проявляется двусторонним опуханием околоушных желёз, в том числе в составе синдрома Хеерфордта — Вальденстрёма.

Дифференциальная диагностика

1. хронический сиалоаденит;
2. туберкулёз;
3. болезнь кошачьей царапины;
4. актиномикоз;
5. синдром Шегрена.

Поражение черепных нервов — самое частое проявление нейросаркоидоза (50% случаев), чаще всего лицевого, затем зрительного нерва. Паралич лицевого нерва обычно проходит за несколько месяцев даже без лечения. Описаны потеря слуха (VIII нерв), лицевая боль и нарушения чувствительности (V нерв).

Ознобленная волчанка (lupus pernio) — хроническое рецидивирующее поражение кожи носа, щёк, ушных раковин и пальцев. Поражённые участки уплотнены; их цвет красный, пурпурный или фиолетовый. Часто сочетается с поражением лёгких, костей и глаз и резистентна к лечению.

Периферические лимфатические узлы поражаются в 10–25%, чаще задние и передние шейные и надключичные: плотноэластические, не размягчаются и не образуют свищей. Обнаружение эпителиоидно-клеточных гранулём в удалённом узле требует дифференциальной диагностики с саркоидной реакцией и другими гранулематозами.

2.6 Внелёгочные локализации

Кожа (10–30%): узлы, бляшки, «ожившие рубцы», гранулёмы в татуировках; узловатая эритема саркоидных гранулём не содержит. Глаза (5–25%): передний (70–75%) и задний увеит — требуют офтальмологического обследования. У детей до 5 лет характерна триада: увеит, поражение кожи, артрит без поражения лёгких.

Сердце (2–18%) — жизнеугрожающая локализация: нарушения ритма и проводимости, внезапная смерть. Нервная система (5–10%) — краниальные нейропатии, асептический менингит, гипоталамо-гипофизарная дисфункция. Почки, печень, селезёнка, кости (кистоидный остеит фаланг), суставы — по органам.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается по жалобам, анамнезу, лучевым, функциональным, лабораторным и морфологическим данным и требует исключения саркоидной реакции и сходных заболеваний. Верификация — гранулёмы без казеозного некроза хотя бы в одном органе при характерной клинико-рентгенологической картине.

Синдром Лёфгрена, синдром Хеерфордта, ознобленная волчанка и бессимптомная двусторонняя внутригрудная лимфаденопатия настолько специфичны, что позволяют поставить предположительный диагноз без морфологического исследования.

Диагноз устанавливает и формулирует пульмонолог медицинской организации 2–3 уровня после обследования.

3.2 Осмотр кожи, лимфоузлов и глаз

Всем пациентам — физикальное обследование всех органов и систем.

На что обратить внимание

1. изменения кожи, особенно в области старых рубцов и татуировок;
2. безболезненные подвижные увеличенные периферические лимфоузлы, подкожные саркоиды Дарье — Русси;
3. конъюнктива и радужка — увеит, эписклерит;
4. размеры печени и селезёнки.

3.3 Анализы крови и мочи

Всем пациентам — общий анализ крови: повышение СОЭ при остром течении, лимфопения и моноцитоз как признаки активности, тромбоцитопения при поражении печени, селезёнки, костного мозга.

Всем пациентам — оценка функции почек (общий анализ мочи, креатинин, мочевина, СКФ) при первичной диагностике и **не реже 1 раза в 6 месяцев**.

Подросткам и взрослым — активность АПФ при выявлении и в динамике как маркер активности, не как дифференциально-диагностический критерий. Норма **в 6–18 лет** — 29–112 ед., **старше 18 лет** — 20–70 ед.; значимо повышение более 150% от верхней границы нормы.

При остром саркоидозе — С-реактивный белок: умеренное повышение характерно для синдрома Лёфгрена.

Кальций крови и суточной мочи при выявлении и в динамике: гиперкальциемия (5%) и гиперкальциурия (25%) — признаки активного процесса.

Иммуноглобулины A, M, G при первичном обследовании — дифференциальная диагностика с иммунодефицитами, сопровождающимися гранулёмами (ОВИН).

Исключение туберкулёза

1. детям **до 7 лет** — проба Манту с 2 ТЕ (при активном саркоидозе отрицательна в 80–85%);
2. всем при первичной диагностике обязательна проба с аллергеном туберкулёзным рекомбинантным;
3. при отказе от кожных проб или их невозможности — IGRA-тесты;
4. положительный результат — углублённое обследование у фтизиатра.

3.4 Рентгенография и компьютерная томография органов грудной полости

Обзорная рентгенография — всем для первичной диагностики и определения стадии; для наблюдения — только если КТ невозможна. Типично симметричное увеличение лимфоузлов корней лёгких и средостения и (или) двусторонние очагово-интерстициальные изменения при относительно удовлетворительном состоянии.

КТ органов грудной полости — всем для первичной диагностики и динамического наблюдения. Характерны увеличенные лимфоузлы центрального средостения и корней лёгких без перифокальной инфильтрации и перилимфатические мелкие очаги вдоль бронхососудистых пучков, междолевых щелей и плевры.

3.5 Другие методы визуализации

МРТ сердца и (или) головного мозга — при подозрении на саркоидоз сердца и ЦНС; ПЭТ-КТ всего тела — для уточнения локализации и выбора места биопсии (накопление ФДГ не отличает саркоидоз от опухоли или инфекции).

При подозрении на генерализованный или внелёгочный саркоидоз — УЗИ брюшной полости, МРТ головного мозга и сердца, эхокардиография, рентгенография и МРТ поражённых костей и мягких тканей.

3.6 Функция внешнего дыхания и ЭКГ

Всем при первичной диагностике, вне зависимости от локализации, — спирометрия (ФЖЕЛ, ОФВ1/ФЖЕЛ): **не реже 1 раза в 3 месяца** в активной фазе и ежегодно при наблюдении. DLco — в пульмонологических центрах. Пульсоксиметрия — на всех этапах, при необходимости тест с 6-минутной ходьбой.

ЭКГ — обязательный компонент первичного обследования; при нарушениях ритма — холтеровское мониторирование.

3.7 Биопсия

Бронхоскопия с биопсией — всем на этапе первичной диагностики; метод биопсии выбирают по ситуации: прямая, чрезбронхиальная, тонкоигольная биопсия лимфоузлов, криобиопсия.

Всем обязательно исключение туберкулёза в биоптатах и промывных водах бронхов: микроскопия, посев, ПЦР.

При неинформативности эндоскопической биопсии — миниинвазивные хирургические операции: видеоторакоскопическая резекция лёгкого, биопсия внутригрудных лимфоузлов.

При внелёгочном саркоидозе — биопсия поражённого органа: периферического лимфоузла, кожи, подкожных образований, печени; метод выбирают лечащий врач и хирург.

3.8 Дифференциальная диагностика

1. **внутригрудная лимфаденопатия** — туберкулёз, нетуберкулёзный микобактериоз, бруцеллёз, токсоплазмоз, болезнь Кикучи, болезнь кошачьей царапины, саркоидная реакция при карциноме, лимфомы, острый лимфобластный лейкоз, GLUS-синдром, IgG4-ассоциированное заболевание, ОВИН
2. **диссеминация в лёгких** — туберкулёз, микозы, опухолевая диссеминация, гиперчувствительный пневмонит, пневмокониозы, лекарственные реакции, гистиоцитоз X, гранулематоз с полиангиитом (Вегенера), интерстициальные пневмонии, ОВИН
3. **дети до 5 лет** — увеиты, паротиты, артриты и поражения кожи другой этиологии

---

4. Лечение

Этиотропной терапии нет. Активная терапия показана при угрозе недостаточности органов, угрозе жизни или потере качества жизни; в остальных случаях — активное наблюдение. Необходимость лечения соотносят с тяжестью последствий глюкокортикоидной, цитостатической или биологической терапии.

4.1 Активное наблюдение

Бессимптомным пациентам (детям и взрослым) без недостаточности органов — активное наблюдение с оценкой **через 3 месяца**: частота спонтанных ремиссий высока.

Взрослым с бессимптомным течением без функциональных нарушений в качестве альтернативы — #альфа-токоферола ацетат или его сочетание с #пентоксифиллином не менее **6 месяцев**.

1. #альфа-токоферола ацетат — в разделе 3.1 указано «200 мкг 2 раза в сутки» и, ниже, «200–400 мг в сутки» (см. «Неточности»);
2. #пентоксифиллин — в разделе 3.1 указано «400–2000 мкг в сутки» и, ниже, 600–1200 мг в сутки (при стероидзамещающей терапии — до 2000 мг).

4.2 Системные глюкокортикоиды

Препараты первой линии при прогрессирующем течении, выраженных симптомах, внелёгочных проявлениях с нарушением функции органа, lupus pernio, угрозе жизни или резком снижении качества жизни.

1. преднизолон взрослым — внутрь утром 20–40 мг в сутки (0,5 мг/кг) **4 недели**, затем снижение по 5 мг в месяц до минимальной поддерживающей дозы, всего **12–24 месяца**.

Эффект оценивают **через 3 месяца**, при его отсутствии переходят на альтернативную терапию. После отмены обострения развиваются у 30–80%. О полной ремиссии судят **через 3 года** после прекращения терапии.

Нежелательные явления: повышение артериального давления и глюкозы, увеличение массы тела, остеопороз (бисфосфонаты), надпочечниковая недостаточность.

Ингаляционные глюкокортикоиды как основная терапия не рекомендуются; их назначают при выраженном кашле и при саркоидозе гортани. Комбинации с бронхолитиками — только при доказанной обратимой бронхообструкции.

4.3 Препараты второй и третьей линии

#Метотрексат — препарат второй линии (при рефрактерности, побочных реакциях или для снижения дозы глюкокортикоидов) и первой линии в монотерапии или комбинации; тератогенен.

1. #метотрексат — внутрь 10–15 мг 1 раз в неделю; взрослым при нейро- и кардиосаркоидозе — до 25 мг в неделю;
2. #фолиевая кислота — 5 мг 1 раз в неделю или 1 мг ежедневно, не ранее чем через 24 часа после метотрексата; терапия от 6 месяцев.

До лечения — АЛТ, АСТ, креатинин, общий анализ крови; в ходе лечения — **каждые 1–3 месяца**.

Другие препараты второй линии

1. #азатиоприн — **с 3 лет**, 100–200 мг в сутки не менее 6 месяцев;
2. #лефлуномид — **с 18 лет**, 10–20 мг в сутки, эффект не ранее 3 месяцев;
3. #микофенолата мофетил — **с 12 лет**, 500 мг 2 раза в день с увеличением до 750–1000 мг 2 раза в день;
4. #циклофосфамид — 500–1000 мг внутривенно каждые 3–4 недели при полиорганном поражении и рефрактерности;
5. #гидроксихлорохин — **с 6 лет**, 400 мг с возможным снижением до 200 мг в сутки, 6–12 месяцев; при саркоидозе глаз не рекомендуется (ретинопатия).

Ингибиторы ФНО-альфа — третья линия только при рефрактерном саркоидозе в профильных центрах: #инфликсимаб 3 или 5 мг/кг внутривенно на 0-й, 2-й и 6-й неделе, затем каждые 4–8 недель; #адалимумаб 40 мг в неделю.

НПВП — симптоматически при острых формах и артритах с выраженным болевым синдромом, по инструкции.

Антифибротическая терапия — только взрослым при прогрессирующем фиброзе, несмотря на глюкокортикоиды и препараты второй линии.

4.4 Другие методы лечения

При хроническом рефрактерном саркоидозе — плазмаферез (3–4 процедуры с недельным перерывом) или экстракорпоральная модификация лимфоцитов.

Трансплантация лёгких — при терминальной стадии (IV, фиброз); сердца — при кардиосаркоидозе с рефрактерными нарушениями ритма; печени — при тяжёлом поражении.

При дыхательной недостаточности — низкопоточная оксигенотерапия, в тяжёлых случаях неинвазивная ИВЛ до SpO_2 более 90%; при лёгочной гипертензии — по рекомендациям по лёгочной артериальной гипертензии.

Всем пациентам — немедикаментозные программы: физическая активность, физическая и психологическая реабилитация, группы поддержки, лечение боли и нарушений сна.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Плановая госпитализация — первичная комплексная, в том числе инвазивная, диагностика и подбор начальной терапии. Экстренная — острый прогрессирующий саркоидоз с осложнениями (дыхательная недостаточность, нарушения ритма). В большинстве случаев лечение амбулаторное.

Показания к выписке

1. завершение диагностики и установление клинического диагноза;
2. назначение лечения;
3. компенсация острого состояния и осложнений, ставших причиной госпитализации.

5.2 Диспансерное наблюдение

Наблюдение пожизненное: при торакальных формах — пульмонолог, при генерализованных и внеторакальных — пульмонолог и специалист по соответствующей локализации.

Частота осмотров

1. впервые выявленный, первый год и сохраняющаяся активность — **каждые 3 месяца**;
2. стабилизация на 2-м году — **каждые 6 месяцев**, далее ежегодно;
3. рецидивы — каждые 3 месяца **2 года**, затем ежегодно;
4. прогрессирующее течение — каждые 3 месяца 2 года, затем каждые 6 месяцев 2 года, далее ежегодно.

Пациенты с саркоидозом относятся к иммунокомпрометированным; вакцинация — по национальному календарю и календарю по эпидемическим показаниям с учётом периода болезни и терапии.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Саркоидоз»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 26.12.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2028 года
Код в рубрикаторе	736_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российское респираторное общество; Российское научное медицинское общество терапевтов; Педиатрическое респираторное общество; Российское общество фтизиатров; Российское общество рентгенологов и радиологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Дозы #альфа-токоферола ацетата и #пентоксифиллина в разделе 3.1 указаны в микрограммах («200 мкг 2 раза в сутки», «400–2000 мкг»), а ниже в том же разделе — в миллиграммах («200–400 мг в сутки», «600 мг в сутки», «до 2000 мг»); различие в тысячу раз.